Station 2

Din nästa patient på hälsocentralen är 5-åriga Adam som kommer tillsammans med en förälder. Adam har haft snuva sedan två dagar. I natt fick han feber 38,7 °C, han har sovit mycket oroligt och klagat på ont i örat.

Du ska:

- **Ta relevant anamnes**
- **Undersöka barnet**
- **Informera föräldern om diagnos och vidare handläggning**

Station 2 Pediatrik - Akut mediaotit hos ett förskolebarn, 07/05/2025 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar åldersadekvat och riktad anamnes: allmäntillstånd, feber, infektionstäcke, smärta, förluster, bakgrund	1	0.5	0
Utför åldersadekvat status	1	0.5	0
Utför otoskopisk undersökning på ett korrekt sätt (0.5p), inklusive instruktion till förälder om hur barnet ska hållas (0.5p)	1	0.5	0
Konstaterar ensidig akut mediaotit (bilder)	1	- NA -	0
Rekommenderar febernedsättande och smärtlindring	1	- NA -	0
Rekommenderar rikligt med vätska (0.5p), högt läge vid sömn, eventuellt näsdroppar (0.5p)	1	0.5	0
Informerar vårdnadshavare om diagnosen och behandling på ett lämpligt sätt	1	0.5	0
Rekommenderar ny läkarbedömning snarast vid försämring (0.5p) eller senast inom 2-3 dygn vid utebliven förbättring (0.5p)	1	0.5	0
(Vid förfråga) informerar att antibiotika inte behövs (0.5p) och att öroninflammation ofta läker spontant (0.5p)	1	0.5	0
(Vid förfråga) förklarar att blåsljud över hjärtat hos barn hörs ofta vid infektion och feber (0.5p), oftast benign, rekommenderar omauskultation i friskt skede (0.5p)	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 3

På kirurgmottagningen finns en 75-årig patient med en mörkbrunt pigmenterad hudförändring på underarmens dorsalsida, 2 cm i diameter. Förändringen har funnits i ungefär 3-4 år men har senaste tiden börjat klia och har ökat i storlek. Du vill därför ta bort förändringen och skicka den till histopatologisk analys.

Det finns flera sprutor/kanyler/ampuller med läkemedel att välja bland på rummet.

Du ska:

- **Ta relevant anamnes**
- **Beskriva för patienten hur ingreppet genomförs och eventuella risker**
- **Ge adekvat information om fortsatt handläggning efter att förändringen är borttagen och såret suturerat**
- **Visa vilken spruta/kanyl/ampull med läkemedel du tänker använda**
- **Visa hur du bedövar området för att kunna ta bort hudförändringen**

Låtsas att sprutan är fylld med tillräcklig mängd av det läkemedel du valt, du behöver inte fylla sprutan. Hudområdet är sprittvättat inför din ankomst och vi utgår från att du har skyddsutrustning.

Station 3 Kirurgi - handläggning av hudtumör och utförande av lokalbedövning, 07/05/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Relevant anamnes (tidigare sjukdomar, aktuella läkemedel och eventuella allergier)	2	1	0
Förklarar hur ingreppet går till (ev. risker och hur lång det tar)	2	1	0
Info om suturtagning (cirka 10-14 dagar), histopatologisvar och ev. behov av utvidgad excision	2	1	0
Rätt val av anestesimedel, spruta och kanyl	2	1	0
Adekvat infiltrationsanestesi (iakttar renlighetsprinciper och säkerhet, undviker intravasal administrering och bedövar hela området)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 4

Du är läkare på medicinmottagningen och träffar en 55-årig patient som har haft typ 1-diabetes i 30 år. Han har en mild diabetesretinopati, men för övrigt inga kända komplikationer till sin diabetes. Han kommer på ett extrabesök, då han har haft smärtor i höger fot sedan ungefär en vecka och oroar sig för diabetesrelaterade fotproblem.

Du ska:

- **Ta en anamnes riktad på patientens fotbesvär**
- **Göra en undersökning av patientens fötter.** Berätta högt vad du gör och vad du hittar.
- **Kommunicera fortsatt utredning och handläggning med patienten**

Station 4 Internmedicin - diabetesfot, 07/05/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

	4 poäng	3 poäng	2 poäng	1 poäng	0 poäng
Tar upp en relevant och strukturerad anamnes för det aktuella förloppet	4	3	2	1	0

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Fotinspektion angående rodnad, svullnad	0.5	- NA -	0
Fotpalpation angående värmeökning	0.5	- NA -	0
Undersökning (minst ett av följande: felställningar, behåring, fotsvett)	0.5	- NA -	0
Palpation av fotskelett med samtidig lokalisation av smärta genom patienten	1	0.5	0
Korrekt undersökning av fotpulsar på rätt lokalisation	0.5	- NA -	0
Korrekt undersökning av vibrationskänsel på rätt lokalisation	0.5	- NA -	0
Korrekt undersökning med monofilament	0.5	- NA -	0
Gör en adekvat plan för fortsatt utredning	1	0.5	0
Förklarar tydligt för patienten undersökningsfynd och planering	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 6

Du är ortopedjour på ett länssjukhus. En 32 årig kvinna söker med akut insättande lumbago-ischias sedan natten till idag. Hon har en svår smärta från rygg ut i vänster ben.

Undersökningsresultat från triagen på akuten:
Temp 36,7 ºC, P-CRP 1 mg/L (referens <3).
Vitalparametrar är normala.

Du ska:

- **Ta adekvat anamnes**
- **Utföra ett riktat status.** Berätta högt vad du gör.
- **Informera patienten om preliminär diagnos och vidare handläggning**

Station 6 Ortopedi - Ryggstatus Ortopeden Akutmottagning, 07/05/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
ryggstatus; Innefattar... samt föreslår även PR-undersökning.	1	0.5	0
Neurologisk us motorik L4-S1	1	0.5	0
Neurologisk us sensorik L4-S1	1	0.5	0
Neurologisk us reflexer patella och Akilles	1	0.5	0
Tar adekvat anamnes som innefattar tidigare sjukdomar, inklusive symtom på malignitet samt symtom för cauda-equina påverkan	3	1.5	0
Information till patienten och vidare utredning med akut MR. Inläggning på sjukhus.	2	1	0
Personcentrerat förhållningssätt.	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 7

Du arbetar som läkare på akutmottagningen vid ett mindre sjukhus och har med dig en läkarstudent från termin 11.

Läkarstudenten vill diskutera två patienter som precis har gjort en röntgen av höftled respektive datortomografi (DT) - undersökning av hjärnan.

Du ska:

- **Bedöma röntgenbilder och välja rätt diagnos**
- **Demonstrera fynden för studenten**

Station 7 BFM - två fall, 07/05/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

Fall 1	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Moment 1 **Diagnosalternativ (max 2p)** Korrekt diagnos, subaraknoidal blödning = 2 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	2	- NA -	0
Moment 2 **Demonstration av fynd (max 1p)** Demonstrerar blödningsfynd adekvat = 1 poäng. Bristande demonstration = 0 poäng.	1	- NA -	0
Moment 3 **Tolkning av fynd (max 1p)** Ej blod, förkalkningar i plexuschoroideus. Förnekar blod, anger förkalkningar = 1 poäng. Förnekar blod, anger annan rimlig genes/förklaring = 0,5 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	0.5	0
Moment 4 **Vidare utredning (max 1p)** Föreslår vidare utredning med antingen DT angio eller konventionell angio = 1 poäng. Föreslår inläggning med kontroller och eventuell ny DT = 0,5 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	0.5	0
Feedback..			

Fall 2	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Moment 1 **Diagnosalternativ (max 2p)** Korrekt diagnos, cervikal femurfraktur= 2 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	2	0
Moment 2 **Demonstration av fynd (max 1p)** Demonstrerar fraktur adekvat = 1 poäng. Bristande demonstration = 0 poäng.	1	0
Moment 3 **Vidare handläggning (max 1p)** Föreslår inläggning och/eller operation = 1 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	0
Moment 4 **Vidare utredning (max 1p)** Anger CT och/eller MR som komplement = 1 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	0
Feedback..		

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 9

Din nästa patient på vårdcentralen kommer för fortsatt handläggning då distriktssköterskan vid två tillfällen har mätt upp ett förhöjt blodtryck på 165/90 mmHg.

Patienten är 40 år och har för 10 år sedan fått diagnosen systemisk lupus erytematosus (SLE) och behandlas sedan dess med hydroxyklorokin (Plaquenil®). Enligt journalen har patienten mått bra avseende sin SLE de senaste åren.

Inga blodprover är tagna eller andra undersökningar gjorda inför dagens besök.

Aktuellt blodtryck idag är 170/95 mmHg.

Du ska:

- **Komplettera anamnesen**
- **Föreslå och motivera fortsatt handläggning för patienten**

Du ska INTE göra något status

Station 9 Reumatologi - SLE och kardiovaskulär riskökning, 07/05/2025 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Professionellt och empatiskt förhållningssätt i konsultationen	1	0.5	0
Adekvat SLE-anamnes för att utröna om aktuell sjukdomsaktivitet (trötthet, ledbesvär, hudutslag, skummande urin etc)	1	0.5	0
Adekvat anamnes kring kardiovaskulära riskfaktorer (rökning, hereditet, fysisk aktivitet)	1	0.5	0
Beställer prover för bedömning av njurpåverkan (krea, urinsticka)	1	0.5	0
Beställer prover för bedömning av kardiovaskulär primärpreventeion (Blodfetter)	1	0.5	0
Adekvat anamnes kring tidigare och nuvarande läkemedel (nsaid inkl receptfritt, kortison mm)	1	0.5	0
Förklarar på ett för patienten förståeligt sätt avseende kardiovaskulär riskökning vid SLE (behöver inte kunna redogöra för de bakomliggande mekanismerna men tydligt förklara att en riskökning föreligger)	2	1	0
Förklarar på ett för patienten förståeligt sätt avseende kardiovaskulär primärprevention (framtida risker)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 10

En 18-årig kvinna kommer på akuttid till dig på hälsocentralen på grund av huvudvärk som tilltagit senaste veckan. Idag på morgonen har hon också mått illa.
Du har gjort ett somatiskt status som är normalt inklusive neurologiskt status. Du tänker gå vidare med direkt oftalmoskopi.

Du ska:

- **Ta kort riktad anamnes**
- **Undersöka ögonbotten i ett öga med direkt oftalmoskopi.** Ögat är en attrapp.
- **Berätta för patienten vad du ser under undersökningen**
- **Kommunicera med patienten om fortsatt handläggning**

.

Station 10 Ögon - Direkt Oftamoskopi, 07/05/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Adekvat anamnes (debut, karaktär, provocerande faktorer, trauma samt patientens farhågor och förväntningar	2	1	0
Adekvat oftalmoskopi	3	1.5	0
Konstaterar en normal papill och informerar om diagnosen på ett förståeligt sätt	2	1	0
Föreslår en adekvat fortsatt handläggning med god patientcentrering	3	1.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 12

Din nästa patient på medicinakuten kommer på grund av orkeslöshet och trötthet. Från triagen har du fått vitalparametrar:

- Temperatur 37,2 °C
- Andningsfrekvens 16 /minut
- Blodtryck 165/95 mmHg, puls 40 /minut

Ett EKG är taget och finns inne på rummet.

Du ska:

- **Ta anamnes**
- **Efterfråga resultat av statusundersökningar** (du behöver INTE utföra status)
- **Tolka EKG**
- **Kommunicera din bedömning och planering för fortsatta åtgärder med patienten**

Station 12 Kardiologi - AV-block 3, 07/05/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

	3 poäng	2 poäng	1 poäng	0 poäng
Förmåga att ta adekvat anamnes	3	2	1	0
Adekvat EKG-tolkning	- NA -	2	1	0
Föreslår rimliga utrednings/behandlingsåtgärder	3	2	1	0
Informerar patient på ett för patienten begripligt sätt	- NA -	2	1	0
Feedback..				

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 13

En 65-årig lärare med tablettbehandlad hypertoni kommer till dig på Hälsocentralen på grund av tilltagande andfåddhet sedan cirka ett halvt år tillbaka. Var från början andfådd vid lättare ansträngning men har nu problem att hänga med jämnåriga vid promenad.

Status:

Allmäntillstånd: Opåverkad i vila, BMI 24, syremättnad på luft i vila 94%. Hjärta: Regelbunden rytm, inga blåsljud.
Blodtryck: 130/85 mmHg.
Lungor: Väsentligen normala andningsljud, vid forcerad exspiration något förlängt exspirium utan distinkta ronki.

EKG: Sinusrytm, frekvens 88 /minut. Inga uppenbara avvikelser.

Du ska:

- **Ta adekvat anamnes**
- **Kommunicera din bedömning och planering för fortsatta åtgärder med patienten**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Frågar efter Riskfaktorer A	1	0.5	0
B	0.5	- NA -	0
Symtombild C	1	0.5	0
D	1	0.5	0
Informera om Diagnos A	1	0.5	0
Diagnos B	2	1	0

	1.5 poäng	1 poäng	0.5 poäng	0 poäng
Utredning C	1.5	1	0.5	0

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Professionalitet	2	1	0

Feedback..

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 14

Harald, 18 år kommer till dig på hälsocentralen på grund av trauma mot näsa i samband med innebandyspel igår. Näsan är svullen, lätt sned. Harald är ordentligt nästäppt i vänster näspassage sedan händelsen. Nästäppan på vänster sida har succesivt blivit mer uttalad.

Du ska:

- **Ta en kort riktad anamnes**
- **Göra riktad statusundersökning på docka, och tolka resultatet av undersökningen**
- **Utföra relevant åtgärd/behandling alternativt remittera för detta och tolka resultatet av denna**
- **Informera patienten om mest trolig diagnos och vidare handläggning**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Harald har en näsfraktur med felställning.	2	1	0
Examinanden säger att hen undersöker näsan med nässpekula samt pannlampa och tolkar nässtatus som svullet och misstänker septumhematom. Bedömaren/figuranten visar bilder på septumhematom.	2	1	0
Examinanden säger att hen utför punktion alt insicion och visar hur hen gör detta alt. remiss till ÖNH. Bedömaren/figuranten informerar att det tömmer sig blod från hematomet.	2	1	0
Examinanden säger att hen tamponerar näsan samt ordinerar antibiotika alt. remiss till ÖNH	2	1	0
Examinanden anger varför man ska sätta in åtgärd/behandling (näsfraktur/septumhematom)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 16

Du arbetar på kirurgen och har varit med och opererat Erik Andersson, 38 år gammal. Erik opererades i 6 timmar för pankreascancer. Operationen såg till en början ut att ha gått väl men efter att Erik flyttades till uppvakningsavdelning drabbades han oväntat av en kraftig inre blödning och dog. Hans anhörige har nyss kommit till sjukhuset.

Du ska:

- **Informera Eriks anhörig om dödsfallet på ett professionellt sätt**
- **Bemöta reaktioner och frågor i samtalet**
- **Erbjuda lämpliga stödjande åtgärder**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Bekräftelse av identitet Tillfredsställande: Bekräftar att den anhörige är rätt person att ge informationen till genom att fråga om namn och relation till patienten. Ej tillfredsställande: Missar att säkerställa att informationen ges till rätt person.	1	- NA -	0
Empati Tillfredställande: Visar tydlig empati, upprätthåller ögonkontakt. Bekräftar den anhöriges reaktioner och erbjuder adekvat emotionellt stöd. Delvis tillfredsställande: Visar viss empati men brister i något moment. Ej tillfredsställande: Visar bristande empati, ger beskedet på ett abrupt sätt, eller undviker ögonkontakt.	2	1	0
Strukturering av dödsbeskedet Tillfredställande: Inleder med ett varningsskott, ger information i en logisk ordning, lämnar ett tydligt besked om att patienten har dött. Delvis tillfredsställande: Försöker strukturera samtalet men ger vissa delar av informationen på ett mindre tydligt sätt eller i ologisk ordning. Ej tillfredsställande: Ger beskedet utan tydlig struktur eller förankring.	2	1	0
Hantering av den anhöriges reaktion Tillfredställande: Bekräftar och validerar reaktioner, ger utrymme för den anhörige att reagera, låter hen ställa frågor, erbjuder sig att upprepa informationen vid behov. Delvis tillfredsställande: Möter den anhöriges reaktion men går vidare i samtalet utan att tydligt bekräfta eller ge utrymme för sorgeprocessen. Ej tillfredsställande: Ignorerar eller avbryter den anhöriges reaktion och pressar vidare med information.	2	1	0
Språk och ordval Tillfredsställande: Använder lättbegripligt språk: Undviker helt eller förklarar tydligt medicinska facktermer, säger "avlidit/dött" istället för bara "gått bort" eller "somnat in" för att minimera missförstånd. Ej tillfredsställande: Använder olämpligt språk: Talar i medicinska termer utan att förklara eller använder vaga uttryck som kan orsaka förvirring.	1	- NA -	0
Praktisk uppföljning och stöd Tillfredsställande: Erbjuder relevant stöd. Informerar om möjligheter till fortsatt hjälp (t.ex. kurator, präst, kontakt med vården i senare skede för frågor) och säkerställer att den anhörige har förstått informationen. Delvis tillfredsställande: Informerar om stöd men gör det på ett otydligt sätt eller utan att säkerställa att informationen förstås. Ej Tillfredsställande: Ger ingen vägledning.Informerar inte om stöd eller möjlighet till fortsatt kontakt.	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 17

En 81-åring har varit inlagd i tre dagar för höga blodglukosvärden. Med dropp, insulin och metformin har glukos gått ned fint. Ska åka hem idag med nyinsatt T. Metformin 500 mg × 2.

Vid hemgång klagar patienten över sveda vid vattenkastning som ökat i frekvens och ömhet över urinblåsan. Symtomen fanns före inläggning på sjukhuset men har tilltagit. Är feberfri.

Urinsticka har visat positiv nitrit, urinodling är skickad.

Du ska:

- **Genomföra ett utskrivningssamtal, där du:**
  - **Informerar om vårdtiden, aktuella sjukdomar samt nyinsatta läkemedel**
  - **Handlägger patientens symtom på urinvägsinfektion**
  - **Kommunicerar fortsatt planering och uppföljning med patienten**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Informera om vårdtiden och kontrollera att patienten förstått vad som hänt	1	0.5	0
Efterfrågar antibiotika allergier	1	- NA -	0
Föreslår lämpligt antibiotika för uvi	1	- NA -	0
Informera om läkemedel, syfte och biverkningar (för tre poäng behövs råd att ta paus med Metformin vid magsjuka)	3	1.5	0
Informera om planen att uppföljning sker på hälsocentralen diabetessköterska	1	0.5	0
”Red flags” – vad kan gå snett och hur agerar patienten då	1	0.5	0
Kolla att patienten förstått (patienten sammanfatta för poäng)	1	0.5	0
Bemötande av äldre patient	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 19

Din nästa patient på akutmottagningen kommer på remiss från vårdcentralen efter att ha skurit sig.
Patienten har rensat fisk och skulle hugga fast kniven i en bräda men gled och skar sig i lill- och ringfinger. Sårskadan är tejpad och täckt med förband på hälsocentralen.

Du ska:

- **Komplettera anamnesen**
- **Utföra ett för skadelokalisationen relevant handstatus**
- **Ange dina fynd så att patienten förstår**
- **Kommunicera vad som är skadat och fortsatt handläggning med patienten**

Det du ser/hittar på patientens hand är vad du ska kunna se.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
När? Antibiotika? Tetanus? Allergi AB el LA	2	1	0
Tar av förband/inspektera sår	1	- NA -	0
Kapillär återfyllnad: trycker på fingerblomma eller nagel, bedömer återflödet	1	- NA -	0
Sensorik rad+uln digitalnerver dig 4-5: 2-punktsdiskrimination med mätare	1	0.5	0
FDP: böja DIP-lederna, FDS: böja minst pekfingrets PIP-led m övriga DIP låsta i extension,	2	1	0
Rätt bedömning: cirkulation normal digitalnerver Samtliga 4-5 på digskadade senor FDP+FDS 4-5 avskurna	1	0.5	0
Rätt information och handläggning remiss för operation Kontrollera alt ge antibiotikaprofylax	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 20

Du är kirurgjour på akuten. Ambulanshelikoptern har just kommit in med en 56-årig man som ramlat sex meter från ett tak (hände 150 km från sjukhuset). Det finns en övervakningsjournal från helikoptern.

Du ska:

- **Utföra strukturerad primär undersökning**
- **Vidta adekvata åtgärder**
- **Informera akutsköterska om din bedömning och fortsatt handläggning**

Patienten är en docka, men du ska utföra dina åtgärder som det vore en riktig patient. Det finns en sköterska på rummet som ger dig de uppgifter/information/fynd som dockan inte kan förmedla.

Station 20 An/Iva- Fallolycka, 07/05/2025 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Orienterar sig/bekräftar vad som hänt	1	0.5	0
Airway – identifierar korrekt huruvida att det föreligger en fri luftväg	1	- NA -	0
Breathing – identifierar påverkad respiration	1	- NA -	0
Breathing – ger patienten syrgas	1	- NA -	0
Cirkulation – identifierar påverkad cirkulation	1	- NA -	0
Disability – tar ett grovt neurologiskt status: medvetandegrad, pupiller, grovmotorik. Bekräftar normala förhållanden.	1	- NA -	0
Information till sköterska: cirkulatoriskt påverkad patient, adekvat rapport	1	0.5	0
Föreslår korrekt vidare handläggning till sjuksköterska, tydliga ordinationer, god kommunikation	2	1	0
Korrekt ordning på ABCDE-momenten	1	- NA -	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10